



Delirium em idosos

Definição

É uma alteração aguda, uma síndrome neuropsiquiátrica aguda. Sem etiologia específica caracterizada pela presença simultânea de perturbações da consciência e da atenção, da percepção, do pensamento, da memória, do comportamento psicomotor, das emoções e do ritmo sono-vigília. A duração é variável, e a gravidade diferencia-se em formas leves a muito graves.

- **Início: agudo**, geralmente horas a dias, desenvolvimento súbito;
- **Flutuação**: os sintomas variam ao longo dos dias, com períodos de melhora e piora;
- Causa orgânica: **secundária a condição** miocárdica, torácica ou metabólica injustificável.

Ponto chave: o delirium não é diagnóstico de exclusão, é uma síndrome com critérios bem definidos e causa orgânica obrigatória.

Epidemiologia

Na população geral, na comunidade, gira em torno de 1-2% dos idosos.

Delirium é extremamente prevalente em idosos hospitalizados e está associado a desfechos graves, frequentemente subdiagnosticado pela equipe de saúde, em que até 70% dos casos passam despercebidos, sendo o delirium hipoativo o que mais é deixado passar.

1/3 de incidência hospitalar, 80% em pacientes idosos internados em UTI.

O risco de morte é duplicado em relação a idosos sem delirium.

Os grupos de maior risco incluem pacientes pós-operatórios, internados em UTI, com demência prévia e em uso de múltiplos fármacos (quanto mais medicamento, maior risco do paciente ser afetado).

Quanto maior a idade, maior o risco. Poderia ser prevenido em até 40% dos casos.

Quadro clínico

Disfunção global da cognição é uma manifestação essencial: o prejuízo do pensamento encontra-se invariavelmente presente, tornando-se vago e fragmentado, variando de lento ou acelerado, nas formas leves, a sem lógica ou coerência, nas formas graves. A memória apresenta-se comprometida e associa-se diretamente a prejuízo da atenção e do nível de consciência.

A apresentação clínica varia conforme o subtipo psicomotor, o que frequentemente leva ao subdiagnóstico a forma hipoativa, a mais comum e a menos reconhecida.

▼ Hiperativo (25%)

Quadro de:

- Agitação;
- Agressividade;
- Alucinações visuais;
- Hipervigilância.

É o mais fácil de identificar.

▼ Hipoativo (50%)

- Sonolência;
- Letargia;
- Redução da resposta a estímulos.

Obs: a agitação pode ser mais ao final da tarde e a noite, com inversão do período sono-vigília.

Obs: é o mais grave e o mais subdiagnosticado.

▼ Misto (25%)

Alternância entre períodos de agitação e sonolência com curso flutuante bem marcado.

Etiologia e fatores de risco

O delirium resulta da interação entre fatores predisponentes (vulnerabilidade basal do paciente) e fatores precipitantes (insulto agudo).

Qualquer condição que comprometa a função cerebral pode causar delirium, embora, em geral, resulte de uma quantidade limitada de condições clinicamente comuns.

▼ Fatores predisponentes

- Idade avançada: ≥ 65 anos;
- Demência ou comprometimento cognitivo prévio;
- Déficits sensoriais: visão e audição;
- Imobilidade e dependência funcional;
- Desnutrição e desidratação;
- Comorbidades múltiplas: doenças hepáticas propiciam a encefalopatia hepática, por exemplo;
- Depressão;
- Uremia;
- Doença grave: apache > 16 ;
- Alcoolismo: mesmo poucas quantidades;
- Histórico de delirium prévio.

▼ Fatores precipitantes

- Infecção: ITU, pneumonia, sepse;
- Cirurgia e anestesia: especialmente ortopédica;
- Fármacos psicoativos e polifarmácia;
- Distúrbios metabólicos: hiponatremia (hidroclorotiazida e anti-hipertensivos podem causar) e hipoglicemia;
- Dor não controlada;
- Privação de sono e imobilização;
- Desidratação;

- Mudança de ambiente;
- Cateter urinário, sonda nasogástrica e contenção física.

Regra prática: quanto maior a vulnerabilidade basal, menor o insulto necessário para desencadear o delirium. E quanto maior o insulto maior o risco de desenvolver delirium.

Fisiopatologia

Manifestação neuropsiquiátrica não específica por um distúrbio do metabolismo cerebral e da neurotransmissão.

A síndrome é mais bem caracterizada por **5 domínios principais**:

- Déficits cognitivos;
- Déficits de atenção;
- Desregulação do ritmo circadiano;
- Desregulação emocional;
- Alteração do funcionamento psicomotor.

A fisiopatologia ainda não é bem compreendida mas há hipóteses que tentam explicar:

- **Hipótese do envelhecimento neuronal:**

Associadas à diminuição fisiológica da reserva funcional, tornando o paciente idoso mais vulnerável ao estresse físico e à doença, e incluem diminuição na proporção de neurotransmissores reguladores de estresse, redução do fluxo sanguíneo cerebral, diminuição da densidade vascular, perda de neurônios e de sistemas de transdução de sinal intracelular.

- **Hipótese neuroquímica:** deficiência da acetilcolina, aumento da dopamina, elevação/redução da serotonina/GABA, redução da histamina e aumento do glutamato;

A deficiência de acetilcolina parece ser um dos mecanismos mais importantes. Anormalidades da transmissão colinérgica podem promover principalmente a diminuição dos níveis de consciência e de excitabilidade, bem como o prejuízo da memória.

A serotonina tem efeito inibitório, sendo postulado que o sistema serotoninérgico tem função estabilizadora no processo de informação, na deficiência de serotonina, os indivíduos tornam-se distractíveis, impulsivos e com reação exaltada. Além disso, parece ser um dos componentes na modulação do ciclo sono-vigília, ajudando a causar o sono normal.

O GABA, principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central (SNC), tem sido relacionado ao delirium em condições nas quais sua atividade está aumentada, como na encefalopatia hepática, ou diminuída, como na abstinência de benzodiazepínicos ou álcool.

A histamina tem participação na regulação hipotalâmica do ciclo sono-vigília.

- **Hipótese neuroinflamatória:**

A resposta inflamatória causa permeabilidade aumentada da barreira hematoencefálica, com isso há ativação das células da glia que propiciam a liberação de mediadores inflamatórios e ROS causando disfunção neuronal.

- **Hipótese neuroendócrina:**

O aumento do corticoide e manutenção de níveis elevados causando uma resposta aberrante ao estresse e levando ao dano neuronal.

- **Hipótese do estresse oxidativo:**

Sugere que, com a diminuição do metabolismo oxidativo cerebral, ocorre uma cascata de eventos de vários sistemas que incluem a incapacidade de manter gradientes iônicos, causando diminuição, e a propagação de impulsos corticais, anormalidades na síntese, metabolismo e liberação de neurotransmissores, produção de radicais livres e acúmulo de subprodutos neurotóxicos.

- **Hipótese da desregulação do ritmo circadiano:**

O estresse oxidativo e corticoide causam alteração na produção da melatonina e causam alteração na arquitetura do sono.

Os mecanismos centrais envolvem redução da acetilcolina e aumento da dopamina, bem como disfunção de redes, neuroinflamação e estresse metabólico.

Diagnóstico

Há duas etapas essenciais: estabelecer o diagnóstico síndrômico e determinar a sua etiologia. O diagnóstico síndrômico é realizado com base em história, exame físico e pela aplicação dos critérios diagnósticos específicos, que podem ser realizados por instrumentos de avaliação. O diagnóstico etiológico é feito a partir de investigações clínica e laboratorial.

▼ DSM-5

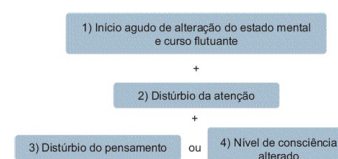
Os critérios DSM-5 fornece os critérios diagnósticos padronizados, são **5 critérios obrigatórios** sendo todos necessários para o diagnóstico formal.

- a. Atenção e consciência → distúrbio da atenção com dificuldade de focar manter ou direcionar a atenção, e do nível de consciência;
- b. Início agudo → desenvolvimento em curto período de horas a dias, com flutuação ao longo do dia;
- c. Cognição → déficit cognitivo adicional como memória, orientação, linguagem, percepção ou visoespacial;
- d. Não explicado por outro transtorno → distúrbios dos critérios A e C não são explicados por transtornos neurocognitivos pré-existentes;
- e. Causa orgânica: evidência de condição médica, intoxicação, abstinência ou causa multifatorial.

▼ CAM/ Confusional Assessment Method

É um instrumento de rastreio mais validado para o delirium, com sensibilidade de 94-100% e especificidade de 90-95%.

O diagnóstico se dá com o critério 1 + 2 + 3 ou 4.



1. Início agudo e curso flutuante: mudança aguda do estado mental basal com flutuação ao longo do dia. Perguntar ao cuidador: "o paciente está diferente do habitual?";
2. Desatenção: dificuldade em focal, manter ou direcionar a atenção. Teste dizer os meses do ano ao contrário ou sequência de letras;

3. Pensamento desorganizado: discurso incoerente, irrelevante ou ilógico.
Perguntas simples de sim/não e seguir sequência de comandos;
4. Nível de consciência alterado: qualquer resposta diferente de alerta como vigilante (hiperativo), letárgico, estuporoso ou comatoso.

▼ Diagnóstico diferencial

O principal desafio diagnóstico é distinguir delirium de **demência, depressão e psicoses funcionais**.

Característica	Delirium	Demência	Depressão
Início	Agudo/horas a dias	Insidioso de meses/anos	Subagudo/semanas
Curso	Flutuante, reversível	Progressivo e irreversível	Diurno, estável
Atenção	Gravemente alterada	Relativamente preservada	Levemente alterada
Consciência	Rebaixada ou alterada	Preservada até fases tardias	Preservada
Alucinações	Visuais, frequentes	Menos comuns	Auditivas, raras
Causa orgânica	Sempre identificável	Degenerativa	Funcional/psiquiátrica

A demência é o principal fator de risco para delirium, os dois diagnósticos podem coexistir e o delirium sobreposto a demência tem pior prognóstico.

Prevenção

A prevenção é a estratégia mais eficaz, é a intervenção de maior impacto no delirium. O protocolo HELP, baseado em evidências, reduz a incidência em até 40% através de intervenções não farmacológicas multicomponentes.

- **Estimulação cognitiva:** orientação frequente para tempo, espaço e pessoa, conversas sobre temas familiares, calendários e relógios visíveis no quarto;
- **Mobilização precoce:** encorajar a deambulação assim que possível, com fisioterapia motora e respiratória desde o primeiro dia, evitar contenção física;

- **Higiene do sono:** reduzir ruídos e interrupções noturnas, evitar procedimentos à noite, ajustar medicamentos que interferem no sono;
- **Correção sensorial:** disponibilizar óculos e aparelho auditivo se necessário, com iluminação adequada, reduzir os estímulos desnecessários a noite
- **Hidratação e nutrição:** manter hidratação adequada e monitorar a ingesta alimentar, avaliar a necessidade de suplementação;
- **Revisão farmacológica:** suspender ou reduzir fármacos psicoativos, anticolinérgicos e benzodiazepínicos, realizando desprescrição ativa.

Obs: mas cuidar que se já fizer uso crônico das medicações psicoativas, talvez retirar não seja a melhor opção.

Tratamento

O tratamento é fundamentalmente não farmacológico, sendo o farmacológico reservado para situações de risco à segurança do paciente ou sofrimento intenso, com evidências limitadas, sendo mais reservado para casos de delirium hiperativo.

▼ Não farmacológico

- Identificar e tratar causa de base;
- Reorientação frequente e contato familiar;
- Ambiente calmo, iluminado e familiar;
- Mobilização precoce e fisioterapia;
- Correção de déficits sensoriais;
- Evitar cateter vesical e contenção física;
- Manter ciclo sono-vigília.

▼ Farmacológico

- **Haloperidol:** 0,5-1 mg VO/IM é a droga de escolha para agitação intensa, causa menor sedação que outros antipsicóticos. Evitar em parkinson e sempre preferir VO;

Obs: nunca EV pelo risco de morte por uma arritmia de torsades de pointes.

- **Quetiapina** 12,5-25 mg VO na prática é o mais usado, sendo preferível em parkinsonismo e mais sedativo;
- Risperidona: 0,5 mg VO é uma alternativa oral.

Evitar benzodiazepínicos (pode acentuar a agitação), exceto se abstinência em que podemos usar o Lorazepam, evitar também anticolinérgicos, anti-histamínicos e sedativos.

Prognóstico

O delirium é marcador de gravidade e preditor independente de desfechos adversos.

A mortalidade hospitalar é aumentada em 2-10x durante a internação, com risco mantido por até 12 meses após a alta.

Há maior dependência funcional, com perda de autonomia das atividades de vida diárias, maior necessidade de institucionalização e cuidados de longa duração.

Além disso, há aceleração da demência pré-existente, com risco aumentado de um novo comprometimento cognitivo em 6 meses.

A hospitalização é até 3x mais longa, com maior taxa de complicações nosocomiais e readmissionais.

Basicamente, o delirium raramente é benigno. Mesmo episódios breves estão associados a declínio cognitivo e funcional permanente em idosos.



Caso 1: homem, 78 anos, 2o dia pós-operatório de artroplastia de quadril. A família relata que ele não está ele mesmo, sonolento, pouco responsivo e não reconhece familiar.

Raciocínio: início agudo + desatenção + alteração de consciência indica CAM positivo e possivelmente é hipoativo. As causas podem ser dor, opióides, privação de sono, imobilização.

Tratamento: suspender morfina, mobilização precoce, reorientação e investigar infecção.

Caso 2: mulher, 82 anos, trazida ao PS por agitação intensa, alucinações visuais e tentativa de sair da cama. Sem febre com urina turva. Mini-mental anterior de 26/30.

Raciocínio: ITU é precipitante clássico em idosas.

Contuda: pedir urocultura e iniciar antibioticoterapia associada a medidas não farmacológicas. Associar Haloperidol 0,5 mg de risco de queda/autolesão.

Caso 3: homem, 84 anos, 12 medicamentos, internado por dispneia. Apresenta alternância entre agitação diurna e sonolência noturna. Sem infecção identificada.

Raciocínio: revisar a lista de medicamentos, paciente fazia uso de amitriptilina, prometazina e alprazolam que são medicamentos com carga anticolinérgica e sedativa elevada. Paciente com CAM positivo para forma mista.

Tratamento: desprescrição.